

//Раздел 1. Воспаление. МРК. Лихорадка (ЛФ-ОПК-5, ИД-2 ОПК-5; МПФ – УК-1, ИД-1, ИД-2, ИД-3, ОПК-5, ИД-1, ИД-2, ИД-3)

Какие из указанных клеток относятся к "клеткам хронического воспаления»: {

=Тучные клетки

=+Макрофаги

=Нейтрофилы

=Базофилы

=Эозинофилы

}

Какие признаки могут свидетельствовать о наличии воспалительного процесса в организме: {

=Эритроцитоз

=+Лихорадка

=Гипопротеинемия

=Ишемия

=Стаз

}

Какие из перечисленных веществ принято относить к медиаторам воспаления: {

=Na⁺

=H⁺

=K⁺

=Нуклеиновые кислоты

=+Лимфокины

}

Хроническое воспаление характеризуется: {

=+Образованием воспалительных гранул

=Снижением проницаемости сосудистой стенки

=Повышением проницаемости стенки сосудов

=Накоплением в очаге воспаления нейтрофилов

=Эозинофилией

}

Запуск острого воспаления происходит: {

=С территории соединительной ткани

=+"От сосудов"

=С территории эпителиальной ткани

=С территории нервной ткани

=С территории костно-мозговой ткани

}

Причины повышения венозного давления в поздние сроки воспаления: {

=Усиление притока

=Сужение просвета сосудов

=+Нарушение оттока

=Расширение просвета сосудов

=Ускорение притока и оттока

}

Причины болезненности при воспалении: {

=Повышение чувствительности болевых рецепторов

=+Раздражение рецепторов кислыми продуктами и сдавление их отеком жидкостью

=Повышенная возбудимость ЦНС

=Парабиотические изменения в рецепторах

=Возбуждение чувствительных корешков

}

Экссудат, содержащий много эритроцитов: {

=Серозный

=Гнилостный

=Фибринозный

=+Геморрагический

=Гнойный

}

Причины повышения кровяного давления в зоне артериальной гиперемии: {

=+Усиленный приток крови

=Застой крови

- =Возбуждение сосудодвигательного центра
- =Спазм сосудов
- =Потеря эластичности стенки сосудов

}

Какие белки выходят в первую очередь из сосудов при экссудации: {

- =+Альбумины
- =Глобулины
- =Фибриноген
- =С-реактивный белок
- =Протамины

}

Как называется жидкость, вышедшая из сосудов при воспалении: {

- =Фибринозная жидкость
- =Геморрагическая жидкость
- =Серозная жидкость
- =+Экссудат
- =Транссудат

}

Чем характеризуется альтеративное воспаление: {

- =Преимущественными явлениями экссудации и инфильтрации
- =+Преимущественно явлениями дистрофии, некробиоза и некроза
- =Преимущественно пролиферативными явлениями
- =Выраженной сосудистой реакцией
- =Выраженными дистрофическими и пролиферативными явлениями

}

Чем характеризуется гиперергическое воспаление: {

- =Слабыми проявлениями, не соответствующими силе действующего агента
- =Адекватностью проявлений силе раздражителя
- =Отсутствием реакций на действие агента
- =+Чрезмерно сильной реакцией организма
- = Гипоергией

}

Что приводит к припухлости (отеку): {

=Застой крови

=Набухание ткани

=Замедление лимфооттока

=+Выход жидкости из сосудов

=Пролиферация клеточных элементов

}

Какие процессы наиболее интенсивно выражены при хроническом воспалении: {

=Альтеративные

=Альтеративные и пролиферативные

=Экссудативные

=+Пролиферативные

=Альтеративные и экссудативные

}

Какие лейкоциты эмигрируют из сосудов в ранний период воспаления: {

=Лимфоциты

=Моноциты

=Эозинофилы

=Базофилы

=+Нейтрофил

}

Что такое экссудация: {

=Выпотевание жидкости

=+Выход жидкой части крови при воспалении

=Выход крови из сосудов

=Накопление серозной жидкости

=Выход лимфы в воспалительную ткань

}

При каком виде воспаления проницаемость сосудов выражена больше: {

=Серозном

=Гнойном

=+Геморрагическом
=Фибринозном
=Гнилостном
}

Эксудат, содержащий мало белка и клеточных элементов: {
=Гнойный
=+Серозный
=Геморрагический
=Фибринозный
=Гнилостный
}

При каком виде воспаления в экссудате много фибриногена: {
=Серозном
=Геморрагическом
=Гнойном
=+Фибринозном
=Гнилостном
}

Вид экссудата, содержащий большое количество лейкоцитов: {
=Серозный
=Фибринозный
=Геморрагический
=+Гнойный
=Серозно-фибринозный
}

Что такое эмиграция лейкоцитов: {
=Выход жидкости из сосудов
=Выход эритроцитов
=+Выход лейкоцитов
=Выход белков плазмы
=Выход тромбоцитов
}

Чем отличается экссудат от транссудата: {

=Большим содержанием белка в транссудате

=Отсутствием форменных элементов

=Большим удельным весом транссудата

=+Большим содержанием белка и форменных элементов

=Меньшим удельным весом экссудата

}

Укажите последовательность эмиграции лейкоцитов в очаг острого воспаления: {

=Моноциты, лимфоциты, нейтрофилы

=Нейтрофилы, лимфоциты, моноциты

=Лимфоциты, нейтрофилы, моноциты

=Моноциты, нейтрофилы, лимфоциты

=+Нейтрофилы, моноциты, лимфоциты

}

Укажите факторы, обуславливающие боль при воспалении: {

=Действие катионных белков

=+Механическое раздражение нервных окончаний экссудатом

=Гиперонкия

=Простагландины

=Повышение температуры тела

}

Какие факторы способствуют развитию отека в очаге воспаления: {

=Повышение онкотического давления крови

=Снижение онкотического давления межклеточной жидкости

=Снижение осмотического давления межклеточной жидкости

=+Повышение онкотического давления межклеточной жидкости

=Алкалоз

}

Острое воспаление характеризуется: {

=Образованием гранулемы

=Эмиграцией в очаг эозинофилов

- =+Эмиграцией в очаг нейтрофилов
- =Инфильтрацией очага мононуклеарными лейкоцитами
- =Эмиграцией лимфоцитов

}

Хроническое воспаление характеризуется: {

- =+Образованием воспалительных гранул
- =Снижением проницаемости сосудистой стенки
- =Повышением проницаемости стенки сосудов
- =Накоплением в очаге воспаления нейтрофилов
- =Эозинофилией

}

Какие процессы преобладают при хроническом воспалении: {

- =+Пролиферативные
- =Альтеративные
- =Сосудистые
- =Сосудисто-экссудативные
- =Экссудативные

}

Какая клетка является ведущей в развитии острого воспаления: {

- =Активный макрофаг
- =+Нейтрофил
- =Тучная
- =Лимфоцит
- =Эозинофил

}

Причины повышения венозного давления в поздние сроки воспаления: {

- =Усиление притока
- =Сужение просвета сосудов
- =+Нарушение оттока
- =Расширение просвета сосудов
- =Ускорение притока и оттока

}

Какая теория в патогенезе воспаления отводит основную роль явлениям фагоцитоза: {

=Конгейма

=Вирхова

=Шаде

=+Мечникова

=Риккера

}

Экссудат, содержащий много эритроцитов: {

=Серозный

=Гнилостный

=Фибринозный

=+Геморрагический

=Гнойный

}

Чем характеризуется нормергическое воспаление: {

=+Соответствием проявлений воспаления силе раздражителя

=Преобладанием проявлений воспаления над силой агента

=Слабыми, не соответствующими силе действия агента, проявлениями

=Отсутствием реакции на действие агента

=Гиперергией

}

Причины повышения кровяного давления в зоне артериальной гиперемии: {

=+Усиленный приток крови

=Застой крови

=Возбуждение сосудодвигательного центра

=Спазм сосудов

=Потеря эластичности стенки сосуда

}

Укажите ранние признаки, характеризующие артериальную гиперемию: {

=+Покраснение органа или ткани

- = Цианоз ткани
- = Выраженный отёк ткани
- = Понижение температуры поверхностно расположенных тканей
- = Снижение пульсации

}

Какой вид артериальной гиперемии возникает при наложении медицинских банок: {

- = Нейротоническая
- = Постанемическая
- = +Вакатная
- = Перераспределительная
- = Нейропаралитическая

}

Какие изменения микроциркуляции характерны для артериальной гиперемии : {

- = +Увеличение количества функционирующих капилляров
- = Уменьшение внутрикапиллярного давления
- = Уменьшение фильтрации жидкости из сосудов в ткань
- = Ослабление лимфотока из ткани
- = Маятникообразное движение крови

}

Чем обусловлена алая окраска органа при артериальной гиперемии : {

- = +Увеличением содержания оксигемоглобина в крови
- = Уменьшением содержания оксигемоглобина в крови
- = Увеличением артериовенозной разницы по кислороду
- = Уменьшением объемной скорости кровотока
- = Увеличением содержания восстановленного гемоглобина в крови

}

Повышение температуры органа или ткани в области артериальной гиперемии обусловлено: {

- = +Усилением окислительных процессов
- = Усилением лимфообразования
- = Увеличением артериовенозной разницы по кислороду

- =Усилением лимфотока из ткани
- =Повышением линейной скорости кровотока
- }

Укажите возможные последствия артериальной гиперемии :{

- =Разрастание соединительной ткани
- =Ослабление функции органа
- =+Кровоизлияние
- =Дистрофия тканей
- =Гипотрофия тканей
- }

Укажите признаки венозной гиперемии :{

- =Увеличение количества функционирующих капилляров
- =+Цианоз органа или ткани
- =Понижение тургора тканей
- =Понижение температуры внутренних органов
- =Побледнение ткани
- }

Укажите признаки, характерные для ишемии :{

- =Цианоз органа
- =Увеличение числа функционирующих капилляров
- =Повышение температуры поверхностных тканей
- =+Боль и побледнение органа или ткани
- =Повышение тургора тканей
- }

Какие изменения микроциркуляции характерны для ишемии :{

- =Повышение артериовенозной разницы давлений
- =Повышение внутрисосудистого давления
- =Повышение линейной скорости кровотока
- =+Уменьшение числа функционирующих капилляров
- =Повышение объемной скорости кровотока
- }

Укажите эмболы эндогенного происхождения :{

=+Жировая

=Воздушная

=Микробная

=Газовая

=Инородными телами

}

При каком виде местных расстройств кровообращения наблюдается побледнение тканей :{

=Артериальной гиперемии

=Венозной гиперемии

=Стазе

=+Ишемии

=Тромбозе

}

К первичному стазу относится :{

=Ишемический

=Застойный

=+Истинный

=Застойный

=Вторичный

}

Как называется первый период в течении инфекционных заболеваний?{

=Продромальный

=Период выраженных проявлений

=Завершающий

=+Инкубационный

}

//Раздел 2. Реактивность, Аллергия (ЛФ-ОПК-5, ИД-2 ОПК-5; МПФ – УК-1, ИД-1, ИД-2, ИД-3, ОПК-5, ИД-1, ИД-2, ИД-3)

Как называются реакции II типа по Кумбсу-Джеллу: {

=анафилактические
=клеточные
=+цитотоксическ
=иммунокомплексные
=рецепторно-опосредованные
}

Как называются реакции III типа по Кумбсу-Джеллу: {

=анафилактические
=клеточные
=цитотоксические
=+иммунокомплексные
=рецепторно-опосредованные
}

Как называются реакции I типа по Кумбсу-Джеллу: {

=+анафилактические
=клеточные
=цитотоксические
=иммунокомплексные
=рецепторно-опосредованные
}

Под иммунологической толерантностью понимают: {

=+отсутствие иммунной реакции на антиген
=ослабление иммунной реакции на антиген
=повышение иммунной реакции на антиген
=индукция иммунного ответа
=отсутствие патофизиологической стадии
}

Укажите вид иммунодефицита при агаммаглобулинемии Брутона: {

=клеточный
=+гуморальный
=ретикулярная дисгенезия
=ТКИН

=селективный дефицит IgA
}

Вторичные иммунодефициты могут возникать при: {

=очаговой пневмонии
=бронхитах
=+злокачественных опухолях
=Fe - дефицитной анемии
=гриппе
}

Укажите первичные иммунодефициты: {

=синдром Дауна
=синдром Иова
=СПИД
=+синдром Ди-Джорджи
=синдром Клайнфельтера
}

Антиген - распознающими клетками являются: {

=эритроциты
=базофилы
=+макрофаги
=нейтрофилы
=тучные клетки
}

Антиген - презентирующими клетками являются: {

=эритроциты
=базофилы
=+дендритные клетки
=нейтрофилы
=лимфоциты
}

Какие клетки участвуют в IV-ом типе аллергических реакций (по Кумбсу-Джеллу)

:{

=В - лимфоциты

=эритроциты

=клетки соединительной ткани

=+Т - клетки

=клетки нейроглии

}

К центральным органам иммунной системы относятся: {

=печень

=селезенка

=+костный мозг

=лимфоциты крови

=кишечник

}

К периферическим органам иммунной системы относятся: {

=печень

=+селезенка

=костный мозг

=тимус

=головной мозг

}

К реакциям трансплантат против хозяина (РТПХ) относятся: {

=+гомологичная болезнь

=феномен Овери

=сывороточная болезнь

=феномен Артюса

=анафилаксия

}

Укажите заболевания, развивающиеся по III типу (по Кумбсу и Джеллу): {

=поллинозы

=бронхиальная астма
=контактный дерматит
=+сывороточная
болезнь
=аллергический ринит
}

К заболеваниям аутоиммунной природы относят: {

=поллиноз
=отек Квинке
=крапивница
=+тиреоидит Хашимото
=пневмония
}

Трансплантация каких тканей вызывает развитие РТПХ: {

=стромальных
=эпителиальных
=+селезенки
=клетки крови (лейкоциты и эритроциты)
=кожи
}

Реакции IV типа по Кумбсу и Джеллу называются: {

=анафилактическими
=+клеточными
=цитотоксическими
=иммунокомплексными
=рецепторно-опосредованными
}

Эпитопы – это: {

=+антигенные детерминанты
=антитела
=иммуноциты
=ферменты

=моносахариды
}

Какими клетками обеспечивается клеточный иммунный ответ: {

=+Т - клетками

=В - клетками

=нейтрофилами

=эозинофилами

=базофилами

}

Сущность стадии патофизиологических нарушений: {

=активизация тканевых и клеточных ферментов

=накопление в организме специфических антител

=+реакция поврежденных аллергеном клеток и тканей организма

=быстрое усиление некротических процессов

=индукция выработки антител

}

Сущность стадии патохимических нарушений: {

=+активизация тканевых и клеточных

ферментов

=накопление в организме специфических антител

=реакция поврежденных аллергеном клеток и тканей организма

=быстрое усиление некротических процессов

=выработка сенсibilизированных Т-лимфоцитов

}

Сущность стадии иммунных реакций: {

=активизация тканевых и клеточных ферментов

=+накопление в организме специфических антител

=реакция поврежденных аллергеном клеток и тканей организма

=быстрое усиление некротических процессов

=воспалительные процессы

}

Определение понятия гаптен: {

=полноценный антиген

=вещество, вызывающее активную выработку антител

=+вещество, приобретающее свойства полного антигена после соединения с белками организма

=вещество, образованное из собственных тканей организма под влиянием различных повреждений

=углеводы

}

Примеры аллергических реакций замедленного типа: {

=сывороточная болезнь

=+контактный дерматит

=отек Квинке

=крапивница

=агранулоцитоз

}

Примеры аллергических реакций немедленного типа: {

=+сывороточная болезнь

=контактный дерматит

=реакция отторжения трансплантата

=продуктивное воспаление

=гепатит

}

Воспалительные реакции в состоянии зимней спячки: {

=воспаление протекает так же, как и в норме

=+воспаление протекает медленно

=воспаление приобретает гиперергический характер

=воспаление отсутствует

=при воспалении определяются гранулёмы

}

Что такое гипоэргия : {

=повышенная реактивность

=+пониженная реактивность
=полное отсутствие ответных реакций
=извращенные ответные реакции
=отсутствие ответа организма на флогогенный стимул
}

Что такое гиперергия: {

=+повышенная
реактивность
=пониженная реактивность
=полное отсутствие ответных реакций
=извращенные ответные реакции
=быстрое усиление некротических процессов
}

Реактивность в детском возрасте: {

= +понижена
=повышена
=адекватна реактивности взрослых
=извращена
=отсутствует
}

В каком виде определяется расстройства акта дыхания при бронхиальной астме: {

=возникает инспираторная одышка
=+возникает экспираторная одышка
=возникает смешанная одышка
=возникает периодическое дыхание
=возникает апное
}

Чем характеризуется бронхиальная астма: {

=+внезапным приступом удушья с затруднением выдоха
=затруднением вдоха
=затруднением обеих фаз дыхания
=внезапной остановкой дыхания

=внезапным приступом кашля
}

Причины пассивной сенсibilизации: {

=употребление некоторых пищевых продуктов (мед, яйца и т.д.)
=+введение сыворотки сенсibilизированного организма
=попадание аллергена в организм парентеральным путем
=контакт кожи больного организма с низкомолекулярными веществами
=вдыхание различных пылевых частиц
}

Что такое анергия: {

=состояние повышенной реактивности
=состояние пониженной реактивности
=+полное отсутствие ответных реакций
=извращение ответной реакции
=ослабление ответной реакции
}

Скорость возникновения анафилактического шока: {

=+через несколько секунд после введения разрешающей дозы
= через 1-2 мин. после введения разрешающей дозы
= через 1-2 час. после введения разрешающей дозы
= через 1-2 недели после введения разрешающей дозы
= через 1 месяц
}

Важнейшее условие развития сывороточной болезни: {

= введение лекарственных средств
= циркуляция свободных антител
= наследственные дефекты иммунологической системы
= +повторное введение антигена
= наличие аллергической конституции - предрасположение человека к аллергии
}

В каком организме наиболее интенсивно выражены защитно-физиологические явления: {

- = в одноклеточном
 - = в многоклеточном
 - = в пойкилотермном
 - = +в гомойотермном
 - = у рептилий
- }

Сущность десенсибилизационного метода А.М. Безредко: {

- = введение антигена под наркозом
 - = +дробное парентеральное введение малых доз антигена
 - = введение антигена в ранние сроки сенсibilизации
 - = внутривенное введение больших доз антигена
 - = введение гаптенов
- }

Способы создания десенсибилизации: {

- = +введение антигена по методу А. Я. Безредко
 - = введение антигена внутривенно
 - = введение антигена в оптимальные сроки сенсibilизации
 - = введение больших доз антигена
 - = ликвидация контакта с аллергеном
- }

Патогенез отека Квинке: {

- = нарушается проницаемость сосудов за счет серотонина
 - = расширяются кровеносные капилляры за счет брадикинина
 - = освобождается большое количество жидкости за счет гепарина
 - = меняется холинэстеразная активность тканей
 - = +повышается гидрофильность волокон рыхлой соединительной ткани за счет гистамина
- }

Причина активной сенсibilизации: {

- = употребление некоторых пищевых продуктов (клубника, мед, яйца и т.д.)

- = введение сыворотки сенсibilизированного организма
- = +попадание аллергена в организм парентеральным путем
- = контакт кожи больного организма с низкомолекулярными веществами
- = вдыхание различных пыльных частиц

}

Виды сенсibilизации: {

- = высокая и низкая
- = быстрая и замедленная
- = +активная и пассивная
- = специфическая и неспецифическая
- = видовая и специфическая

}

Способ обнаружения реагинов: {

- = реакция связывания комплемента
- = реакция преципитации
- = реакция агглютинации
- = +реакция Праусница- Кюстнера
- = цитотоксические реакции

}

Наиболее частое проявление анафилактической реакции у человека: {

- = +анафилактический шок
- = сывороточная болезнь
- = феномен Артюса
- = феномен Овери
- = контактный дерматит

}

Определение понятия анафилаксии: {

- = состояние приобретенной повышенной чувствительности к действию собственного белка
- = состояние приобретенной пониженной чувствительности к действию чужеродного белка

- = +состояние приобретенной повышенной чувствительности к действию чужеродного белка
- = генетически обусловленная высокая чувствительность к чужеродному белку
- = состояние гипоэргии

}

Причины идиосинкразии: {

- = +употребление необычной пищи (клубника, мед, яйца и т.д.)
- = введение сыворотки сенсibilизированного организма
- = попадание аллергена в организм парентеральным путем
- = контакт кожи больного организма с низкомолекулярными веществами
- = вдыхание книжной пыли

}

Что такое дизергия: {

- = повышенная реактивность
- = пониженная реактивность
- = полное отсутствие ответных реакций
- = +извращенные ответные реакции
- = реакция агглютинации

}

//Раздел 3. Нарушение водно-солевого равновесия. Влияние внешних факторов (ЛФ-ОПК-5, ИД-2 ОПК-5; МПФ – УК-1, ИД-1, ИД-2, ИД-3, ОПК-5, ИД-1, ИД-2, ИД-3)

Что такое дегидратация:

{

- = Увеличение общего содержания воды в организме
- = + Уменьшение общего содержания воды в организме
- = Отсутствие изменений
- = Уменьшение воды в сосудистом секторе

}

Что такое гипотоническая дегидратация:

{

=+Обезвоживание, когда потеря электролитов превышает потерю воды
=Потеря воды с малым количеством электролитов
=Равномерное снижение количества воды и электролитов
=Уменьшение воды в экстрацеллюлярном русле
=Уменьшение воды в клеточном секторе.
}

Что такое гипертоническая дегидратация:

{
=Дегидратация с преимущественной потерей электролитов
=+Дегидратация с преимущественной потерей воды
=Равномерное снижение количества воды и электролитов
=Уменьшение воды в экстрацеллюлярном русле
=Уменьшение воды в клеточном секторе
}

Что такое изотоническая дегидратация:

{
=Дегидратация с преимущественной потерей электролитов
=Дегидратация с преимущественной потерей воды
=+Равномерное снижение количества воды и электролитов
=Уменьшение воды в экстрацеллюлярном русле
=Уменьшение воды в клеточном секторе
}

Какой вид дегидратации возникает при усиленном потоотделении:

{
=Гипотонический
=Изотонический
=+Гипертонический
=Изоосмолярный
=Гипоосмолярный
}

Какой вид дегидратации возникает при хронической потере воды через желудочнокишечный тракт:

{
=Гипертонический
=+Гипотонический
=Изотонический
=Изоосмолярный
=Гиперосмолярный
}

При каком виде дегидратации нарушения органов проявляются быстрее и протекают тяжелее:

{
=+Изотоническом
=Гипертоническом
=Гипотоническом
=Гипоосмолярном
}

Какие изменения возникают в организме со стороны ССС при обезвоживании:

{
=Увеличение минутного объема сердца
=Увеличение ОЦК
=+Уменьшение артериального давления
=Повышение артериального давления
=Увеличение ЧСС
}

Какие изменения со стороны крови происходят при обезвоживании:

{
=+Сгущение крови
=Понижение свертывающей способности крови
=Разжижение крови.
=Гипокоагуляция
=Ускорение кровотока
}

Укажите начальное звено патогенеза отеков при сердечной недостаточности:

{
=Повышение содержания АДГ в крови
=Повышение секреции ренина в ЮГА почек
=Повышение проницаемости сосудов
=+Снижение минутного объема сердца
=Повышение реабсорбции Na и H₂O в
почечных канальцах
}

Какой фактор является ведущим в развитии аллергических отеков:

{
=+Мембраногенный
=Онкотический
=Осмотический
=Смешанный
=Гемодинамический
}

Какой фактор является ведущим в механизме развития кахектических отеков:

{
=Мембраногенный
=+Онкотический
=Осмотический
=Гемодинамический
=Смешанный
}

Какой фактор является инициальным в механизме развития сердечного отека:

{
=Мембраногенный
=Онкотический
=Осмотический
=+Гемодинамический
=Смешанный
}

Какой фактор является основным в развитии нефритических отеков:

{
=Онкотический
=+Осмотический
=Мембраногенный
=Гидростатический
=Смешанный
}

Какой фактор является основным в развитии нефротических отеков:

{
=+Онкотический
=Мембраногенный
=Смешанный
=Осмотический
=Гидростатический
}

Какой фактор является основным в механизме развития застойных отеков:

{
=Онкотический
=Мембраногенный
=Осмотический.
=+Гидростатический
=Смешанный
}

Какой фактор является основным в механизме развития отеков при циррозе печени:

{
=Онкотический
=Мембраногенный
=Осмотический
=+Смешанный
=Гидростатический
}

Какие отеки по патогенезу развиваются при белковом голодании:

{
=Осмотические
=+Онкотические
=Застойные
=Мембраногенные
=Смешанные
}

Какие отеки по патогенезу развиваются при сердечной недостаточности:

{
=+Осмотические
=Онкотические
=Мембраногенные
=Застойные
=Смешанные
}

Какие отеки по патогенезу развиваются при гломерулонефрите:

{
=Онкотические
=+Осмотические
=Мембраногенные
=Смешанные
=Застойные
}

Какие отеки по патогенезу развивается при аллергических реакциях:

{
=Онкотические
=Осмотические
=+Мембраногенные
=Застойные
=Смешанные
}

Укажите начальное звено в механизме развития нефротического отека:

{
=Увеличение секреции альдостерона
=Увеличение реабсорбции Na и воды в канальцах почек

=Гиповолемия

=+Протеинурия

=Гипопротеинемия

}

Последствия гипогидрии для организма: {

=Гиперволемия.

=+Гиповолемия

=Понижение активности свертывающей системы

=Увеличение скорости кровотока

=Повышение минутного объема сердца

}

Какие изменения возникают на месте контакта с электродом: {

=+Ожоги

=Расслоение ткани

=судороги

=Явление электролиза

=Отрыв тканей или органов

}

Почему при электротравме не ощущается боль: {

=+Парабиотические изменения в рецепторах

=Парезы, параличи

=Деструкция нейронов

=Дегенеративные изменения в тканях

=Гиперстезия

}

При каких условиях человек сталкивается с пониженным барометрическим давлением: {

=+При подъеме на высоту

=В шахтах

=В тесном помещении

=При водолазных работах

=В кессонах

}

Какие компенсаторные механизмы возникают в первой стадии горной болезни: {

=Усиление эритропоэза

=Брадикардия

=+Тахикардия

=Брадипное

=Гиповентиляция

}

Почему возникает эритроцитоз и увеличение Hb в первый период горной болезни:

{

=Перераспределение крови

=Усиливается эритропоэз

=За счет сгущения крови

=+Мобилизация крови из депо

=Усиление выработки эритропоэтина

}

Какие приспособительные явления возникают в позднем периоде горной болезни:

{

=+Усиление эритропоэза

=Запредельное торможение

=Возбуждение ЦНС

=Выброс крови из депо

=Перераспределение крови

}

Какие виды излучения обладают ионизирующей способностью: {

=+Альфа лучи

=Нейтроны

=Позитроны

=Гамма лучи

=Инфракрасные лучи

}

Какие ткани наиболее чувствительны к действию ионизирующего излучения: {

=Хрящи

- =Мышцы
- =Нервная ткань
- =Покровный эпителий
- =+Лимфоидная ткань

}

Какая ткань наиболее чувствительна к действию ионизирующего излучения: {

- =Хрящи
- =Мышцы
- =Нервная ткань
- =Покровный эпителий
- =+Кровотворная ткань

}

Какие сосудистые изменения возникают при солнечном ударе в головном мозге? {

- =Понижение внутричерепного давления
- =+Гиперемия и точечные кровоизлияния в мозговой ткани
- =Обширное кровоизлияние
- =Нарушение оттока крови по венам
- =Развитие гематомы

}

Реакция сосудов на действие холода в первой стадии гипотермии: {

- =Замедление тока крови
- =Расширение сосудов
- =+Спазм
- =Агрегация эритроцитов
- =Стаз

}

Механизм усиления теплопродукции при охлаждении: {

- =Спазм сосудов
- =+Усиление мышечной дрожи, обмена веществ
- =Повышение АД
- =Усиление функции эндокринных желез
- =Усиление потребления кислорода

}

Признаки второй степени отморожения: {

=+Появление пузырей и развитие воспаления

=Венозная гиперемия

=Феномен сладжа

=Некроз

=Гиперемия

}

Признаки третьей степени отморожения: {

=Гиперемия

=+Некроз тканей

=Появление пузырей

=Плазмопотеря

=Стаз

}

Назовите первую фазу в течении ожоговой болезни: {

=Ожоговая токсемия

=Ожоговое истощение

=+Ожоговый шок

=Выпадение функции кожи

=Аутоинтоксикация

}

Как изменяется проницаемость кишечной стенки при ожоговой болезни: {

=Практически не меняется

=Изменяется незначительно

=+Резко повышается

=Резко понижается

=Незначительно понижается

}

Какие сосудистые изменения возникают при солнечном ударе в головном мозге? {

=Понижение внутричерепного давления

- =+Гиперемия и точечные кровоизлияния в мозговой ткани
- =Обширное кровоизлияние
- =Нарушение оттока крови по венам
- =Развитие гематомы

}

Почему нервные клетки при прямом облучении гибнут в последнюю очередь: {

- =Так как обладают интенсивным обменом
- =+Так как не обладают способностью к делению
- =Так как являются высокодифференцированными образованиями
- =Так как нарушается биоэлектрическая активность головного мозга

}

В развитии точечных наружных кровоизлияний преимущественное значение имеет: {

- =Тромбоцитопатия
- =Тромбоцитоз
- =Активизация гиалуронидазы
- =+Тромбоцитопения
- =Эритроцитопения

}

Какие ионизирующие излучения относятся к корпускулярным: {

- =Гамма лучи
- =+Альфа лучи
- =Рентгеновские лучи
- =Инфракрасные лучи
- =солнечные лучи

}

Какие ионизирующие излучения относятся к электромагнитным: {

- =Альфа лучи
- =Бета лучи
- =Протоны
- =+Гамма лучи
- =Инфракрасные лучи

}

Какие изменения в крови возникают в первый период острой лучевой болезни: {

=Лейкопения

=Нейтропения

=+Лимфоцитопения

=Тромбоцитопения

=Эритропения

}

Какова продолжительность первого периода острой лучевой болезни: {

=4-5 дней

=+1-2 дня

=Больше недели

=10-15 дней

=Несколько недель

}

Почему возникает при лучевой болезни геморрагический синдром: {

=Способность тромбоцитов к адгезии снижается

=+Тромбоцитопения

=Способность тромбоцитов к склеиванию снижается

=Снижается активность фибринолиза

=Тромбоцитоз

}

//Раздел 4. Патопфизиология крови, кровообращения (ЛФ-ОПК-5, ИД-2 ОПК-5; МПФ – УК-1, ИД-1, ИД-2, ИД-3, ОПК-5, ИД-1, ИД-2, ИД-3)

Какое изменение в периферической крови может отражать ядерный сдвиг нейтрофилов вправо: {

=увеличение содержания палочкоядерных нейтрофилов

=увеличение метамиелоцитов

= появление миелоцитов

=базофилия

=+гиперсегментация ядер нейтрофилов

}

О чем свидетельствует ядерный сдвиг нейтрофилов вправо: {

=об омоложении клеток нейтрофильного ряда

=о дегенерации нейтрофилов

=+ о старении клеток

=об уменьшении количества сегментоядерных нейтрофилов

}

Укажите причину, которая может привести к сдвигу лейкоцитарной формулы вправо: {

=+радиоактивные воздействия

= действие высоких температур

= понижение напряжения O₂ во вдыхаемом воздухе

= действие кислот, щелочей на организм

= глистные инвазии

}

При агранулоцитозе противоинфекционная устойчивость организма: {

=повышена

=+понижена

=не изменена

=незначительно повышена

=незначительно снижена

}

Укажите, какое заболевание сопровождается развитием абсолютной лимфоцитопении: {

= инфекционный мононуклеоз

= иммунная форма агранулоцитоза

=+острая лучевая болезнь

= гипопластическая анемия

= туберкулез

}

Какое заболевание сопровождается абсолютной нейтрофилией: {

- =+воспаление легких
- = хронический лимфолейкоз
- = туберкулез легких
- = болезнь Иценко-Кушинга
- = анемия

}

Какое изменение в периферической крови отмечается при нейтрофильном лейкоцитозе: {

- = уменьшение процентного содержания лимфоцитов
- = появление полисегментированных нейтрофилов
- = увеличение процентного содержания моноцитов
- = увеличение содержания лимфоцитов
- =+увеличение процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов, метамиелоцитов

}

Изменения белой крови при пернициозной анемии: {

- = лейкоцитоз
- =+лейкопения, гиперсегментация нейтрофилов
- = лимфопения
- = эозинофилия
- = моноцитоз

}

Какая анемия возникает при дефиците внутреннего фактора Кастла: {

- = железодефицитная
- = энзимдефицитная
- =+B12 - дефицитная
- = белководефицитная
- = гемолитическая

}

Какая анемия возникает при дефиците внутреннего фактора Кастла: {

- = железодефицитная
- = энзимдефицитная

=+B12 - дефицитная
= белководефицитная
= гемолитическая
}

Укажите, какое изменение гематологических показателей характерно для острой постгеморрагической анемии (на 7-е сутки):{

= анизоцитоз и пойкилоцитоз эритроцитов
= тромбоцитопения
= нейтропения
= гипербилирубинемия
=+ретикулоцитоз
}

Сразу после острой кровопотери возникает:{

=олигоцитемическая гиповолемия
=полицитемическая гиповолемия
=+простая гиповолемия
=олигоцитемическая нормоволемия
=полицитемическая нормоволемия
}

К каким видам анемий относится острая постгеморрагическая анемия по типу кроветворения:{

=+к регенеративным **!!! выбирайте этот вариант!!!**
=к арегенеративным
=к дегенеративным
=к регенеративным
=к эмбриональным
}

К какому виду анемий относится хлороз:{

=к постгеморрагической
=к гемолитической
=+к железодефицитной
=к анемии вследствие дефицита витамина B12 и фолиевой кислоты

=к гемоглобинозам

}

Анизоцитоз. Определение понятия: {

=различная форма клеток

=+различная величина клеток

=наличие зерен и нитей в эритроцитах

=способность окрашиваться кислой и основной краской

=появление ядерных форм эритроцитов

}

Как называется различная форма эритроцитов: {

=анизоцитоз

=полихроматофилия

=микроцитоз

=макро-мегалоцитоз

=+пойкилоцитоз

}

Анемия. Определение понятия: {

=малокровие

=уменьшение эритроцитов в единице объема

=уменьшение гемоглобина в крови

=+уменьшение гемоглобина, эритроцитов и качественные изменения эритроцитов

=нет правильных вариантов

}

Что такое гематокритное число: {

=+это содержание эритроцитов в общем объеме крови

=процентное отношение гемоглобина к процентному отношению эритроцитов

=степень насыщения гемоглобина эритроцитов

=отношение объема плазмы к общему объему крови

=нет правильного ответа

}

Укажите фактор, имеющий приспособительное значение для организма в ближайшие минуты и часы после острой кровопотери: {

=уменьшение венозного возврата крови

=тканевая гипоперфузия

=+периферическая вазоконстрикция

=брадикардия

=гиповентиляция

}

Сразу после острой кровопотери возникает: {

=олигоцитемическая гиповолемия

=полицитемическая гиповолемия

=+простая гиповолемия

=олигоцитемическая нормоволемия

=полицитемическая нормоволемия

}

При каком виде анемии нарушен обмен витамина В12: {

=при хлорозе

=+при мегалобластической

=при гемолитической

=при постгеморрагической

=при апластической

}

При каком виде анемии нарушен обмен витамина В12: {

=при хлорозе

=+при мегалобластической

=при гемолитической

=при постгеморрагической

=при апластической

}

При какой анемии развивается фуникулярный миелоз: {

=гемолитический

=железодефицитной

- =белководефицитной
- =+пернициозной
- =гипопластической

}

Аритмии вызывают: {

- =+падение ударного объема сердца
- =повышение ударного объема сердца
- =снижение периферического сопротивления сосудов
- =повышение периферического сопротивления сосудов

}

Какие электрокардиографические изменения являются маркерами некроза миокарда? {

- =удлинение интервала P-Q
- =+углубление зубца Q
- =изменение зубца R
- =отсутствие подъема сегмента S-T
- =уширение комплекса QRST

}

Укажите факторы, состояния, которые могут вызывать сердечную недостаточность посредством прямого повреждения миокарда: {

- =недостаточность трикуспидального клапана
- =гипертоническая болезнь
- =+септические состояния
- =стеноз устья аорты
- =недостаточность аортального клапана

}

Атриовентрикулярная блокада первой степени характеризуется: {

- =+удлинением интервала P - Q более 0,1 с.
- =периодическим выпадением комплекса QRST на каждое 2-3 сокращение
- =периодическим выпадением комплекса QRST на каждое 8-9 сокращение
- =диссоциацией сокращений
- =смещением интервала ST

}

Атриовентикулярная блокада второй степени характеризуется: {

=удлинением интервала P - Q до 0,21 с.

=+появлением периодов Венкебаха-Самойлова

=выпадением желудочкового комплекса на каждое 8-9 сокращение

=диссоциацией сокращений

=смещением интервала ST

}

Атриовентикулярная блокада четвертой степени характеризуется: {

=удлинением интервала P - Q до 0,21 с

=появлением периодов Венкебаха-Самойлова

=выпадением желудочкового комплекса на каждое 8-9 сокращение

=+диссоциацией сокращений предсердий и желудочков

=смещением интервала ST

}

При каких состояниях включается гомеометрический механизм компенсации: {

=недостаточность митрального клапана

=+стеноз митрального отверстия

=недостаточность аортального клапана

=недостаточность трикуспидального клапана

=недостаточность клапана легочной артерии

}

При каких состояниях включается гетерометрический механизм компенсации: {

=сужение устья аорты

=стеноз митрального клапана

=+недостаточность митрального клапана

=гипертоническая болезнь

=сужение устья легочной артерии

}

ЭКГ признаки желудочковой экстрасистолы: {

=удлинение интервала P - Q

- =смещение интервала ST ниже изолинии
- =+изменение конфигурации желудочкового комплекса
- =отрицательный зубец T
- =глубокий зубец Q

}

Изменения в крови при инфаркте миокарда: {

- =лекопения
- =эритропения
- =снижение СОЭ
- =эритроцитоз
- =+лейкоцитоз

}

Количество каких ферментов повышено в крови при инфаркте миокарда: {

- =дастаза
- =+АСТ
- =АЛТ
- =щелочная фосфатаза
- =альдолаза

}

Укажите последствия продолжительного приступа пароксизмальной тахикардии: {

- =увеличивается сердечный выброс
- =увеличивается коронарный кровоток
- =+снижается ударный объем сердца
- =увеличивается систолическое АД
- =увеличивается ударный объем сердца

}

Какие виды аритмий относятся к монотопным: {

- =пароксизмальная желудочковая тахикардия
- =АВ-ритм (атриовентрикулярный ритм)
- =идиовентрикулярный ритм
- =+синусовая тахикардия
- =фибрилляция желудочков

}

Какие проявления характерны для левожелудочковой недостаточности: {

=отеки нижних конечностей

=асцит

=+застой в малом кругу

=набухание яремных вен

=гепатомегалия

}

Назовите механизмы срочной кардиальной компенсации при сердечной недостаточности: {

=брадикардия

=гипертрофия миокарда

=увеличение ОЦК

=+тахикардия

=выброс депонированной крови

}

Укажите состояния, сопровождающиеся повышением А/Д: {

=гипотиреоз

=гипокортицизм

=синдром Клайнфельтера

=+тиреотоксикоз

=пангипопитуитаризм

}

О чем свидетельствует появление на ЭКГ отрицательного зубца Т: {

=о некрозе миокарда

=о блокаде проведения импульса

=+об ишемии миокарда

=о проявлении эктопического очага возбуждения в миокарде

=об инфаркте миокарда

}

Какие вы знаете врожденные пороки сердца синего типа: {

- =незаращение овального отверстия предсердной стенки
- =незаращение межжелудочковой перегородки
- =+транспозиция магистральных артерий
- = дефект межпредсердной перегородки
- =коарктация аорты

}

Назовите пороки сердца белого типа: {

- =Тетрада Фалло
- =транспозиция магистральных артерий
- =+дефект межпредсердной перегородки
- =недостаточность клапанов легочной артерии
- =недостаточность клапанов аорты

}

К чему может привести длительная тахикардия при сердечной недостаточности? {

- =к увеличению минутного объема
- =к подъему артериального давления
- =+к нарастанию явлений недостаточности
- =к уменьшению утомляемости сердечной мышцы
- =к увеличению ударного объема

}

Что лежит в основе гипертонической болезни: {

- =увеличение объема циркулирующей крови
- =увеличение числа и силы сердечных сокращений
- =увеличение притока крови в почках
- =гормонально-активная опухоль надпочечников
- =+стойкое повышение тонуса артериол

}

Что такое экстрасистолия: {

- =атипичное распространение возбуждения
- =нарушение пути прохождения импульса
- =+внеочередное сокращение сердца

- =фибрилляция желудочков
- =мерцание предсердий

}

Какие изменения возникают на ЭКГ при мерцании предсердий?{

- =+появляются множество мелких волн на месте зубца Р
- =уменьшается зубец Р
- =удлиняется интервал Р-Q
- =возникает внеочередной комплекс
- =увеличивается зубец Р

}

Что собой представляет кардиогенный шок: {

- =нарушение микроциркуляции в тканях
- =+синдром острой сердечно-сосудистой недостаточности
- =нарушение гемодинамики в малом кругу
- =снижение периферического сопротивления
- =спазм коронарных сосудов

}

//Раздел 5. Патопфизиология дыхания (ЛФ-ОПК-5, ИД-2 ОПК-5; МПФ – УК-1, ИД-1, ИД-2, ИД-3, ОПК-5, ИД-1, ИД-2, ИД-3)

Причиной паренхиматозной дыхательной недостаточности может быть: {

- =стеноз в/дыхательных путей
- =аспирация инородных тел
- =опухоль головного мозга
- =+ателектаз легочной ткани
- =пневмоторакс

}

Нормобарическая форма гипоксии возникает: {

- =при подъеме на высоту
- =при быстром подъеме водолазов
- =+при нахождении человека в замкнутых пространствах
- =при резком снижении общего барометрического давления в барокамерах

=при медленном подъеме на высоту
}

Внешнее дыхание включает: {

=+обмен газов альвеол и кровью малого круга кровообращения

=транспорт CO₂ и O₂

=утилизация O₂ тканями

=сочетание (транспорт CO₂ и O₂), (утилизация O₂ тканями)

=кровообращение легких

}

Как вы понимаете пневмоторакс: {

=скопление крови в плевральной полости

=накопление экссудата в плевральной полости

=+попадание воздуха в плевральную полость

=образование спаек между париетальной и висцеральной плеврой

=попадание инородного тела в плевральную полость

}

Какие приспособительные реакции возникают при гипоксической гипоксии: {

=увеличивается скорость кровотока

=+учащается дыхание и увеличивается минутный объем крови

=повышается внутри - альвеолярное давление

=уменьшается масса циркулирующей крови

=увеличивается диастолический приток Крови

}

Какое влияние на дыхание оказывает внезапное повышение кровяного давления: {

=учащает дыхание

=углубляет вдох

=уменьшается легочная вентиляция

=+возникает остановка дыхания (апноэ)

=увеличивается легочная вентиляция

}

Какой вид гипоксии характеризуется уменьшенной способностью использовать кислород: {

- =анемическая (кровяная) гипоксия
 - =циркуляторная гипоксия
 - =гипоксическая гипоксия
 - =+тканевая (гистотоксическая) гипоксия
 - =смешанная гипоксия
- }

Чаще всего одышка проявляется в виде: {

- =глубокого замедленного дыхания
 - =глубокого и частого дыхания
 - =+поверхностного и учащенного дыхания
 - =поверхностного и уряженного дыхания
 - =периодического дыхания
- }

Чем характеризуется первый период асфиксии: {

- =кратковременной остановкой дыхания
 - =замедлением сердечной деятельности
 - =угасанием основных рефлексов
 - =урежением дыхания
 - =+возбуждением дыхательного центра
- }

В чем заключается защитная роль Кашля: {

- =усиливается присасывающая сила грудной клетки
 - =улучшается приток крови к правому сердцу
 - =+удаляется из дыхательных путей мокрота
 - =усиливаются дыхательные движения
 - =способствует усилению легочной Вентиляции
- }

К чему может привести хронический кашель в пожилом возрасте: {

- =+к эмфиземе легких
- =к ателектазу легких

=к пневмотораксу
=к отеку легких
=к поражению дыхательных мышц
}

Что лежит в основе возникновения периодического дыхания: {
=нехватка углекислоты
=избыток CO₂ и повышенная возбудимость дыхательного центра
=недостаток CO₂
=повышенная возбудимость дыхательного центра
=+понижение возбудимости дыхательного центра и дефицит O₂
}

В чем состоит благоприятное влияние замедленного и глубокого дыхания: {
=в усилении энергетических затрат и уменьшении легочной вентиляции
=в недостаточном использовании дыхательной поверхности
=в увеличении остаточного объема воздуха
=+в увеличении альвеолярной вентиляции и уменьшении энергетических затрат
=в уменьшении энергетических затрат на работу дыхательных мышц
}

Чем характеризуется дыхание Биота: {
=нарастанием глубины дыхания с постепенным уменьшением и паузой
=уреженным (единичным) и усиленным дыханием продолжительными паузами
=+наличием пауз при усиленном и равномерном дыхании
=чередованием усиленного и ослабленного дыхания
=чередованием частых и редких дыхательных движений
=раздражение поверхности альвеол
}

В чем причина кашля: {
=раздражение слизистой носа
=сдавление мелких бронхов
=нарушение кровообращения в дыхательном центре

=+раздражение слизистой трахеи, бронхов
}

Характеристика дыхания Кулсмауля: {

=+уреженное (единичное) и усиленное дыхание с продолжительными паузами
=нарастание глубины дыханий сменяется постепенным уменьшением и паузой
=наличие пауз при усиленном и равномерном дыхании
=чередование усиленного и ослабленного дыхания
=чередование частых и редких дыхательных движений
}

К чему приводит раздражение легочных ветвей блуждающего нерва: {

=к учащению дыхания
=к урежению дыхания
=не оказывает никакого влияния
=+к преждевременному торможению вдоха
=к преждевременному торможению выдоха
}

Как изменяется газовый состав крови при замедлении кровотока: {

=содержание углекислоты увеличивается
=содержание углекислоты уменьшается
=содержание кислорода уменьшается
=увеличивается содержание CO₂ и увеличивается O₂
=+увеличивается содержание CO₂ и уменьшается O₂
}

Как изменяется дыхание при скоплении жидкости в плевральной полости: {

=+дыхание становится поверхностным и частым
=возникает стенотическое дыхание
=дыхание становится глубоким и частым
=дыхание становится глубоким и редким
=возникает инспираторная одышка
}

Основная причина нарушения кровообращения при кашле: {

- =ослабление присасывающей силы грудной клетки
- =+затруднение оттока крови к правому сердцу по венам
- =сдавление легочных сосудов
- =ослабление диастолического опорожнения сердца
- =уменьшение силы сердечных сокращений

}

Какие гуморальные факторы играют основную роль в патогенезе одышки: {

- =+нарушение газового состава крови
- =накопление в крови биологически активных веществ
- =увеличение щелочных резервов крови
- =повышение артериального давления
- =накопление в крови недоокисленных продуктов

}

Как вы понимаете пневмоторакс: {

- =скопление крови в плевральной полости
- =накопление экссудата в плевральной полости
- =+попадание воздуха в плевральную полость
- =образование спаек между париетальной и висцеральной плеврой
- =попадание инородного тела в плевральную полость

}

Чем обусловлено замедление сердечной деятельности во втором периоде асфиксии: {

- =раздражением симпатических нервов
- =+раздражением центра вагуса
- =угасанием всех рефлексов
- =резким торможением коры головного мозга
- =угнетением деятельности вазомоторного центра

}

Укажите признаки, характерные для гипоксии циркуляторного типа: {

- =+снижение линейной скорости кровотока
- =уменьшение артериовенозной разности по кислороду

=уменьшение содержания кислорода в артериальной крови
=алкалоз
=увеличение объемной скорости капиллярного кровотока
}

Укажите возможную причину гипоксии тканевого типа: {

=отравление метгемоглобинообразователями
=+отравление цианидами
=острая кровопотеря
=образование карбоксигемоглобина
=повышение активности ферментов тканевого дыхания
}

Укажите, при какой патологии возникает острая недостаточность внешнего дыхания: {

=гидротораксе
=экссудативном плеврите
=+приступе бронхиальной астмы
=обструктивной эмфиземе легких
=ателектазе
}

Какие Вы знаете метгемоглобино - образователи: {

=мышьяковистые препараты
=антибиотики
=+сульфаниламиды
=витамины группы В
=сочетание (мышьяковистые препараты), (антибиотики)
}

Укажите механизмы, ведущие к увеличению кислородной емкости крови при умеренной повторной гипоксии: {

=увеличение сердечного выброса
=+усиление эритропоэза
=выход депонированных эритроцитов

=повышение объема альвеолярной вентиляции
=сдвиг кривой диссоциации Нв вправо
}

Укажите причины гемического типа гипоксии: {

=отравление СО
=гиповитаминоз В12
=хроническая кровопотеря
=+отравлениеСО и хроническая кровопотеря
=снижение рО₂ в воздухе
}

Укажите причины дыхательного типа гипоксии: {

=снижение рО₂ в воздухе
=отравление СО
=+эмфизема легких
=отравление нитратами
=недостаточность митральных клапанов
}

Укажите причину циркуляторного типа гипоксии: {

=травматический шок
=+миокардит
=хроническая кровопотеря
=отравление нитратами
=острая массивная кровопотеря
}

В каких случаях сродство гемоглобина к кислороду уменьшается: {

=гипокапнии
=+повышении температуры тела
=метаболическом алкадозе
=снижении температуры тела
=уменьшении в эритроцитах 2,3 –дифосфоглицерата
}

Какие изменения с наибольшей вероятностью могут наблюдаться у человека, длительное время проживающего высоко в горах: {

=гиповентиляция легких

=+гипертрофия сердца

=торможение синтеза нуклеиновых кислот и белков

=уменьшение гематокрита

=активация выброса депонированной крови

}

При каких патологических состояниях возникает экспираторная одышка: {

=+при астматоидном бронхите

=при стенозе верхних дыхательных путей при асфиксии в 1-ю стадию

=при обструкции дыхательных путей жидкой пищей

=сочетание (при стенозе верхних дыхательных путей), (при асфиксии в 1-ю стадию)

}

Какой вид одышки возникает при приступах аллергической бронхиальной астмы: {

=частая поверхностная

=частая глубокая

=редкая глубокая

=+с преимущественным нарушением выдоха

=с преимущественным нарушением вдоха

}

Сколько в норме составляет диффузионная способность для кислорода: {

=25 мл/мин/мм рт. ст.

=35 мл/мин/мм рт. ст.

=40 мл/мин/мм рт. ст.

= 45 мл/мин/мм рт. ст.

=+15 мл/мин/мм рт. ст.

}

Сколько в норме составляет диффузионная способность для углекислого газа: {

}

= 100 мл/мин/мм рт. ст.
= 150 мл/мин/мм рт. ст.
= 200 мл/мин/мм рт. ст.
= 250 мл/мин/мм рт. ст.
=+300 мл/мин/мм рт. ст.
}

Какие симптомы являются основными при острой дыхательной недостаточности: {
= дыхание Куссмауля
= дыхание Биота
= тахикардия
= брадикардия
=+нарастающая одышка и цианоз
}

Какой из перечисленных гормонов является местным «венозным» гормоном:
=адреналин
=вазопрессин
=+гистамин
=натрийуретический пептид
=серотонин
}

Какой из перечисленных гормонов является циркуляторным «артериальным» гормоном: {
= серотонин
= брадикини
=+вазопресси
= простагландины
= натрийуретический гормон
}

Как по-другому называют РДС (респираторный дистресс-синдром): {
= шоковое сердце
= легочное сердце
= ДВС-синдром

= шоковая печень
=+шоковое легкое
}

Какой по очередности является стадия в развитии РДС стадия повреждения эндотелия: {
= 2 стадия
= 4 стадия
= 5 стадия
= 3 стадия
=+1 стадия
}

Какой по очередности является стадия в развитии РДС стадия интерстициального отека: {
= 1 стадия
= 4 стадия
= 5 стадия
= 3 стадия
=+2 стадия
}

Какой по очередности является стадия в развитии РДС стадия повреждения клеток альвеолярного эпителия: {
= 4 стадия
= 5 стадия
= 1 стадия
= 2 стадия
=+3 стадия
}

Какой по очередности является стадия в развитии РДС стадия альвеолярного отека:
{
= 5 стадия
= 3 стадия
= 1 стадия
}

= 2 стадия
=+4 стадия
}

Сколько всего стадий существует в развитии РДС (респираторный дистресс синдром): {

= 3 стадии
= 1 стадия
= 2 стадии
= 5 стадий
=+4 стадии
}

Синонимами какого патологического состояния являются термины «кислородное голодание», «кислородная недостаточность», «аноксия»: {

= ацидоз
= алкалоз
= аллергия
= воспаление
=+гипоксия
}

При гипоксической гипоксии парциальное давление кислорода (pO_2) артериальной крови: {

=норма или понижено
=норма или повышено норма
=повышено
=+понижено
}

При циркуляторной гипоксии парциальное давление кислорода (pO_2) артериальной крови: {

= повышено
= понижено
= норма или повышено
= норма или понижено

= +норма
}

При гемической гипоксии парциальное давление кислорода (pO_2) артериальной крови: {

= повышено

= +норма

= понижено

= норма или понижено

= норма или повышено
}

//Раздел 6. Патология физиология пищеварения (ЛФ-ОПК-5, ИД-2 ОПК-5; МПФ – УК-1, ИД-1, ИД-2, ИД-3, ОПК-5, ИД-1, ИД-2, ИД-3)

Укажите проявления панкреатического коллапса: {

= +внезапное падение А/Д

=внезапное повышение А/Д

=внезапная потеря сознания

=аритмия

=тахикардия
}

Назовите вероятную причину нейродинамической анорексии : {

= +торможение пищевого центра при болевых синдромах (почечная колика)

= сознательный отказ от пищи в связи с психическим заболеванием

= она обусловлена нарушением функции рецепторов пищеварительного тракта

= отрицательные эмоции, сильное возбуждение коры головного мозга

= снижение активности пищевого центра

(инфекции интоксикации)

Укажите причины усиления всасывательной функции желудка : {

= +застой пищи, гастриты

= язвенная болезнь 12-перстной кишки

= язвенная болезнь желудка
}

=дуодениты

=гепатиты различной этиологии

}

Что такое стеаторея: {

=пониженное содержание в кале жира и жирных кислот

=+повышенное содержание в кале жира и жирных кислот

=повышенное содержание в кале слизи

=повышенное содержание в кале белков

=повышенное содержание в кале углеводов

}

Чем характеризуется парорексия: {

=возникновением неуголимого голода

=снижением аппетита

=+склонностью к употреблению непищевых веществ

=полным отказом от пищи

=сочетание (снижением аппетита), (полным отказом от пищи)

}

Укажите последствия патологического усиления всасывания в тонком кишечнике

: {

=аутоинтоксикация, сенсibilизация, булемия

=гипотонический синдром, анорексия

=гипопротеинемия, аллергия

= и авитаминозы, высыпания на коже

=+аутосенсibilизация, аллергия, интоксикация

}

Как меняется моторно-эвакуаторная функция желудка при гиперсаливации {

=моторная замедляется, а эвакуаторная ускоряется

=+ускоряются обе функции

=ускоряется моторная, а эвакуаторная замедляется

=замедляются обе функции

=моторно-эвакуаторная функция не Меняется

К чему приводит гипо- и ахолия :{

=замедляется моторика кишечника, развивается метеоризм

=нарушается переваривание и всасывание жиров и витамина B12

=ускоряется моторика кишечника, возникает диарея

=нарушает всасывание углеводов и витаминов группы В

=+приводит к атонии, нарушению переваривания и всасывания жиров, холестерина и витаминов Д, Е, А, К.

}

Укажите возможные причины развития желудочной гипосекреции: {

=избыточная секреция соматостатина

=активная стимуляция парасимпатической системы

=+снижение выработки и выделения гастрина

=увеличение активности гистаминазы

=избыточное выделение адреналина

}

Укажите возможные причины развития желудочной гиперсекреции: {

=избыточная секреция соматостатина

=+увеличение выработки и выделения гастрина

=снижение выработки и выделения гастрина

=увеличение активности гистаминазы

=избыточное выделение адреналина

}

Назовите наиболее частую причину кишечной аутоинтоксикации: {

=снижение секреции желудочного сока

=повышение моторики кишечника

=+ослабление эвакуаторной функции кишечника

=гиперсекреция панкреатического сока

=гипертрофия микроворсинок тонкой кишки

}

Ахилия желудка сопровождается: {

=отсутствием соляной кислоты

=отсутствием ферментов

}

=отсутствием соляной кислоты, наличием ферментов
=+отсутствием соляной кислоты и ферментов
=наличием соляной кислоты и отсутствием ферментов
}

Назовите причины ослабления желудочной перистальтики: {

=повышение активности парасимпатической системы
=+понижение активности парасимпатической системы
=сужение пилорического отверстия
=увеличение в крови инсулина
=введение гистамина или ацетилхолина
}

Eructatio - это :{

=рвота
=икота
=изжога
=+отрыжка
=тошнота
}

Pyrosis – это :{

=рвота
=икота
=отрыжка
=+изжога
=тошнота
}

Ятрогенные "стероидные" язвы вызываются :{

=инсулином
=адреналином
=минералокортикоидами
=+глюкокортикоидами
=половыми гормонами

}

Почему нарушается дуоденальное пищеварение при ахлоргидрии: {

=+снижается секреция панкреатического сока

=увеличивается секреция секретина

=увеличивается секреция гастрина

=увеличивается холецистокинин

=увеличивается мотилин

}

Какой тип желудочной секреции характеризуется избыточным увеличением объема желудочного сока: {

=тормозной

=+возбудимый

=нормальный

=астенический

=инертный

}

Чем характеризуется возбудимый тип желудочной секреции: {

=отсутствием закономерной динамики и объемов секреции на механическое и химическое раздражение

=замедленным нарастанием на механическое и химическое раздражение

=+интенсивным нарастанием секреции на механическое и химическое раздражение

=интенсивным началом и быстрым снижением на химическое раздражение

=адекватной секрецией и на механическое, и на химическое раздражение

}

Чем характеризуется тормозной тип желудочной секреции :{

=отсутствием закономерной динамики и объемов секреции на механическое и химическое раздражение

=+замедленным нарастанием на механическое и медленным его прекращением на химическое раздражение

=интенсивным нарастанием секреции на механическое и химическое раздражение

=интенсивным началом и быстрым снижением на химическое раздражение

=адекватной секрецией и на механическое, и на химическое раздражение
}

Чем характеризуется астенический тип желудочной секреции :{

=увеличенным латентным периодом, замедленным нарастанием секреции,
увеличенным объемом желудочного сока

=+укороченным латентным периодом, интенсивным началом и
быстрым снижением секреции, малым объемом желудочного сока

=отсутствием какой-либо закономерностей динамики и объемов секреции

=укороченным латентным периодом начала секреции и интенсивным
нарастанием, повышенным объемом желудочного сока

=отсутствием желудочного сока на механическое и химическое раздражение
}

Укажите заболевания, которые могут привести к нарушению мембранного
пищеварения: {

=+ферментопатии

=хронический панкреатит

=механическая желтуха

=гастриты

=гемолитическая желтуха

}

При какой патологии наблюдается гипосаливация: {

=+при сиалоаденитах

=при пульпите

=при периодонтите

=при преобладании тонуса парасимпатической системы

=при стоматитах

}

Укажите постренальные причины нарушений функции почек: {

=нервно-психические расстройства

=инфекции

=+нарушение оттока мочи при аденоме простаты

=нарушение системного кровообращения
=при уретрите
}

Укажите ренальные причины нарушений функций почек: {

=нервно-психические расстройства
=+соли тяжелых металлов
=нарушение общего кровообращения
=сужение почечной артерии
=нарушение оттока мочи
}

Какие нарушения характерны для олигоанурической стадии ОПН: {

=метаболический ацидоз
=+увеличение остаточного азота в крови
=гиповолемия
=гипокалиемия
=гипернатриемия
}

При нефротическом синдроме количество белка в крови: {

=не изменяется
=увеличивается
=незначительно уменьшается
=+значительно снижается
=незначительно увеличивается
}

Укажите вероятные механизмы, способствующие реальной гипертензии: {

=+активация ренин-ангиотензиновой системы
=снижение синтеза ренина
=активация калликреин-кининовой системы
=задержка К в организме
=снижение образования альдостерона
}

Укажите патологические компоненты мочи ренального происхождения: {

=непрямой билирубин

=стеркобилин

=уробилин

=+цилиндры

=желчные кислоты

}

Какие изменения в моче характерны для нефритического синдрома: {

=глюкозурия

=кетонурия

=ацетонурия

=+микрогематурия

=макрогематурия

}

Олигурия – это: {

=увеличение количества мочи

=+уменьшение диуреза

=болезненное мочеиспускание

=преобладание ночного диуреза над дневным

=отсутствие мочи

}

Какие вещества накапливаются в крови при снижении скорости клубочковой фильтрации: {

=глюкоза

=+креатинин

=билирубин

=стеркобилин

=молочная кислота

}

Каков диурез при вторичном гиперальдостеронизме: {

=увеличен

=+уменьшен

=неизменен

=незначительно увеличен

=незначительно уменьшен

}

Укажите вероятный механизм поражения клубочков при гломерулонефрите: {

=лекарственный

=нарушение коркового кровообращения

=+поражение базальной мембраны иммунными комплексами

=нарушение оттока мочи

=сужение почечной артерии

}

Как влияет повышение онкотического давления крови на клубочковую фильтрацию: {

=увеличивает

=+снижает

=не снижает

=слегка увеличивает

=слегка снижает

}

Снижение онкотического давления крови: {

=+увеличивает фильтрацию

=снижает фильтрацию

=не изменяет фильтрацию

=незначительно увеличивает фильтрацию

=незначительно снижает фильтрацию

}

Укажите причины тубулопатии :{

=+поражение канальцев

=почечный несахарный диабет

- =поражение клубочков
- =воспаление мочеточников
- =цистит

}

Укажите причины развития анемии при заболеваниях почек: {

- =гемолиз эритроцитов
- =кровопотери
- =+снижение синтеза эритропоэтинов
- =потеря аминокислот
- =недостаток Fe, Cu, Ni

}

Какие причины приводят к ренальной ОПН: {

- =острая сосудистая недостаточность
- =сепсис
- =обструкция мочевыводящих путей
- =+острый гломерулонефрит
- =гиперволемиа

}

Какие причины приводят прerenальной ОПН: {

- =соли тяжелых металлов
- =+эмболия почечной артерии
- =мочекаменная болезнь
- =обструкция мочевыводящих путей
- =сепсис

}

Что является ведущим признаком нефроза: {

- =лейкоцитурия
- =гематурия
- =+протеинурия
- =гипертония
- =гипотония

}

Для нефротического синдрома характерны: {

=+высокая протеинурия

=низкая протеинурия

=гиперальбуминемия

=отсутствие отеков

=гиполипидемия

}

Боль приводит: {

=к увеличению диуреза

=диурез не изменяется

=+к снижению диуреза

=к снижению реабсорбции

=к повышению реабсорбции

}

Никтурия – это: {

=появление в моче эритроцитов

=частое мочеиспускание в дневное время

=болезненное мочеиспускание

=+преобладание диуреза в ночное время

=редкое мочеиспускание в дневное время

}

Олигурия – это: {

=увеличение количества мочи

=+уменьшение диуреза

=болезненное мочеиспускание

=преобладание ночного диуреза над дневным

=отсутствие мочи

}

Что такое уремический синдром: {

=гематурия

=+появление составных частей мочи в крови

=увеличение билирубина в моче

=увеличение холестерина в крови

=уменьшение билирубина в моче

}

Какие причины приводят к преренальной ОПН: {

=соли тяжелых металлов

=+острая сосудистая недостаточность

=мочекаменная болезнь

=обструкция мочевыводящих путей

=сепсис

}